

Pasuruan, 11 Juni 2026

Nomor : 1049/RSPHS/E-PTR/DIR/VI/2026
Lampiran : 1 halaman
Perihal : Pengantar Kronologi

Kepada Yth.

**Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab.Pasuruan**
di Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti adanya pasien meninggal dunia dengan diagnose SSD, maka bersama ini kami sampaikan form kronologi selama pasien dirawat di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo (terlampir) dengan menimbang :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran, Pasal 9 ayat 3 dan 4, pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum (ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular)
2. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2017

Demikian surat ini kami sampaikan, mohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Terimakasih

Hormat Kami,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep

I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	Ns. Sinta Olivia Rahayu, S.Kep
2	Kejadian	Pasien meninggal dunia dengan diagnosa DSS
3	Unit Kerja yang terlibat	IRNA 2B
4	Tanggal Kejadian	2 Mei 2026
5	Nama Pasien	Tn. Cariman
6	No. RM	143032

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

TANGGAL	JAM	KRONOLOGI	STAF YANG TERLIBAT
Rabu, 29/04/2026	14.27	Pasien datang ke IGD dibawa oleh keluarga dengan keluhan Pasien dibawa dengan penurunan kesadaran sejak pukul 13.00 siang ini, diketahui dari keluarga bahwa pasien sempat mengeluh nyeri kepala selama 2 hari terakhir. Keluhan lain: - Demam - Nafsu makan menurun - Lemah anggota gerak disangkal - BAB cair frekuensi >10 kali RPD: HT & DM disangkal TTV awal masuk : GCS : 215 TD : 162/137 N : 96 S : 37,8 RR : 22 Spo2 : 100% GDA Stick 148 mg/dL Dokter IGD memberikan rencana terapi : O2 NRBM 15 lpm IVFD NS 20 tpm Inj. Metamizole 1 gr Inj. Ranitidin 50 mg Laboratorium : DL, GDA, ECG, SGOT, SGPT, UR,CR, SE Radiologi : Foto Thorax AP	dr. IGD dan perawat IGD
Rabu, 29/04/2026	14.30	Terapi diberikan kepada pasien	Perawat IGD
	14.30	Dokter IGD mengirimkan konsulan ke dr. Ferry Sp.EM Advice tambahan dari dr. Ferry Sp.Em loading asring 1000 drip ne 0.1–1 mcg/ kg/ mnt	Dokter IGD



		tx lain2 lanjutkan obs	
	14.45	Terapi dr. Ferry Sp.em dimasukkan	Perawat IGD
	16.15	Setelah hasil penunjang selesai, dokter IGD mengirimkan konsulan ke dr. Dimas Sp.Pd	Dokter IGD
	16.30	Tekanan darah pasien sempat menurun drastis hingga 84/56 mmHg sehingga harus diberi obat vasopressor	Perawat IGD
	17.00	Pada saat tengah perawatan di IGD, kesadaran pasien berangsur membaik hingga kesadaran penuh, dengan hasil : TTV : GCS : 4/5/6 TD : 100/70 mmHg on NE 0,1 mcg N : 67 x/menit S : 36 RR : 32 x/menit Spo2 : 98 on NRBM	
	17.30	Dokter Dimas Sp.Pd membalas dan memberikan terapi : Diagnosa : GEA + syok hipovolemik + post DOC ec ? Pdx : ekg ulang ur, cr , ot , pt , se, thorax , dl serial Ptx : ns 2000 cc 2 jam lanjut 30 tpm O2 nasal 4 lpm , ceftri 2x1 g iv metronidazol 3x500 mg po attapulgate 4x2 kp loperamid 2x1 kp omz 2x1 iv ondan 2x4 mg iv metamizol 3x1 iv ne sesuai hemodinamik diet entrasol 6x200 cc konsul dr.dion	Dokter Dimas Sp.Pd
Rabu, 29/04/2026	18.00	Dokter IGD mengirimkan konsulan ke dr Dion Sp.jp	Dokter IGD
Rabu, 29/04/2026	19.00	Dokter dion Sp.Jp memberikan advice : HHD ECG: Normal sinus rhythm (ST-T changes -) CXR: Cardiomegaly Tatalaksana HHD dengan Bisoprolol dan Candesartan inisiasi bila NE sdh stop Bila HR masih dibawah <50 diberikan Inj. Sulfas atropine 1 mg (diulang tiap 5 menit, max 3mg) Dilaporkan bila bradikardi tetap persisten dibawah 50 x/mnt stlh pemberian SA, rencana diberikan drip dopamin 5-	Dokter Dion Sp.Jp



		15mcg/kgbb/mnt	
Rabu, 29/04/2026	19.30	Perawat memberikan terapi dr. Dimas Sp.Pd dan dr. Dion Sp.Jp	Perawat IGD
Kamis, 30/4/2026	02.30	Tanda -tanda vital pasien menurun dengan hasil : TTV : GCS : 456 TD : 61/45 N : 45 RR : 32 S : 36 Spo2 : 99 on NRBM Diberikan terapi : - Loading NS 1000 - Inj. SA 1 mg	Perawat IGD
Kamis, 30/4/2026	08.00	Pasien di pindahkan ke ruang rawat inap	
Kamis, 30/4/2026	08.15	Perawat IGD "SK" operan pasien baru dengan perawat "HS". Pasien atas nama : Tn. Cariman/76thn/BPJS 3 Diagnosa : - DF - Cardiomegali suspek CHF - DSS - Syok Hipovolemik - AKI dd CKD st.3 - Bradikardia DPJP : dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp. PD Konsul : dr. Dion Setiawan, Sp. JP Pasien dibawa dengan penurunan kesadaran sejak pukul 13.00 siang ini, diketahui dari keluarga bahwa pasien sempat mengeluh nyeri kepala selama 2 hari terakhir. Pada saat tengah perawatan di IGD, kesadaran pasien berangsur membaik hingga kesadaran penuh pada pukul 17.00. GDA Stick 148 mg/dL RPD: HT & DM disangkal Riwayat Penggunaan Obat : - Keluhan lain : - Demam - Nafsu makan menurun - Lemah anggota gerak disangkal - BAB cair frekuensi >10 kali Tekanan darah pasien sempat menurun drastis hingga 84/56 mmHg pada pukul 16.30 sehingga harus diberi obat vasopressor TTV saat di IGD :	Perawat IGD HS



	GCS : 8(Somnolen) : (E2V1M5) Tekanan Darah : 162/137 mmHg Nadi : 96 x/menit Respiration Rate : 22x/ menit Suhu : 37,8°C SpO2 : 100% (Room Air) Akral : Hangat Kepala : a/i/c/d +/-/- P.KGB (-) Pasien dicek Laboratorium, DL,GDS hasil laboratorium sebagai berikut: Trombosit : 160.000 Leukosit : 2.700 Pasien dikonsulkan dr. Dimas Aryo Pamungkas Sp.PD by WA di IGD, dan mendapatkan advice: - GEA + syok hipovolemik + post DOC ec ? - Pdx ekg ulang ur, cr , ot , pt , se, thorax , dl serial - Ptx ns 2000 cc 2 jam lanjut 30 tpm , O2 nasal 4 lpm , ceftri 2x1 g iv , metronidazol 3x500 mg po , attapulgite 4x2 kp , loperamid 2x1 kp , omz 2x1 iv , ondan 2x4 mg iv , lengkapi lembar dehidrasi dan observasi rehidrasi ttv produksi urin nya, metamizol 3x1 iv, ne sesuai hemodinamik, diet entrasol 6x200 cc - Konsul dr. Dion Setiawan, Sp. JP Pasien dicekkan UR/CR, SGOT/SGPT, SE, Thorax, dengan hasil yg tidak normal : UREUM : 76 BUN : 36 Kreatinin : 2,49 Natrium : 134 Bacaan Thorax : Cardiomegaly Pasien dikonsulkan dr. Dion Setiawan, Sp. JP by WA di IGD advice: Cariman 76thn - HHD - ECG: Normal sinus rhythm (ST-T changes -) - CXR: Cardiomegaly - Tatalaksana HHD dengan Bisoprolol dan Candesartan inisiasi bila NE sdh stop. Bila HR masih dibawah <50 diberikan Inj. Sulfas atropine 1 mg (diulang tiap 5 menit, max 3mg). Dilaporkan bila bradikardi tetap persisten dibawah 50 x/mnt stlh pemberian SA, rencana	
--	--	--



		diberikan drip dopamin 5-15mcg/kgbb/mnt.	
Kamis, 30/04/2026	08.20	Perawat "HS" melakukan bedside handover dan pengkajian awal keperawatan dengan Perawat "SK" simultan dengan TTV kepada pasien Tn. Cariman didapatkan keluhan : lemas dan sesak Ku lemah GCS 456 TD : 92/56 mmHg N : 63x/mnt S : 37,8C RR : 26x/mnt Spo2 : 95% NRBM 15 lpm Akral hangat	HS
Kamis, 30/4/2026	11.46	Pasien dilakukan visite oleh dr.Dimas.,Sp.PD S : demam, mual-mual, nyeri kepala O : CR= 2,4 , SO2= 93 dengan nrbm TD : 70/49 mmHg Nadi : 110 x/menit Spo2 : 100.00 lpm Suhu : 37.5 C RR : 20 x/menit; Akral : Dingin A : GEA + syok hipovolemik + AKI dd ckd st 3 + cardiomegali + bradikardia P : Pdx= DL serial , BGA, EKG ulang besok ptx= metamizol 3x1 iv , raber dr dion spjp, ne 0,3 mcg , dobutamin mulai 10 mcg , tx lain lanjut	Dr.Dimas.,Sp.PD
Kamis, 30/4/2026	12.57	Perawat "HS" melakukan TTV Keluhan : pasien mengatakan lemas dan sesak GCS : 456 K/u Lemas TD : 92/56 mmHg Nadi : 63 x/menit Spo2 : 95 on NRBM 15 LPM Suhu : 37.8 C RR : 26 x/menit Akral : Dingin	HS
Kamis, 30/4/2026	13.30	Perawat pagi "HS" operan jaga dengan perawat siang "DN" Pasien atas nama Cariman/76thn/BPJS 3 dengan dx DF+Cardiomegali suspek CHF+DSS+Syok Hipovolemik+AKI dd CKD st.3+Bradikardia Perawat "DN" melakukan observasi TTV kepada pasien cariman didapatkan keluhan: lemas dan sesak ku lemah GCS 456 TD: 92/56 mmHg N: 63x/mnt	HS,DN

		S: 36,2 C RR : 25x/mnt Spo2 : 95% NRBM 12 lpm Akral : Dingin Pasien diberikan terapi : NE 0,3 mcg masuk mulai 29/04/2026 jam 21.15 Dobutamin 10 mcg masuk mulai jam 12:00 Rencana : Bisoprolol + Candesartan 8mg bila Norepineprine stop Jika HR kurang dari 50 berikan sulfat atropin 1mg (diulang tiap 5mnt max 3mg) EKG ulang tanggal 01/05/2026	
Kamis, 30/04/2026	16.00	Perawat "DN" memberikan terapi - Metamizole 1gr IV - Metronidazole 500mg tab	DN
Kamis, 30/4/2026	17.27	Perawat Daniel melakukan TTV Keluhan : pasien mengatakan mual , muntah 1x, berisi cairan berwarna kuning dan sisa makanan GCS : 456 K/U Lemah TD : 112/65 mmHg Nadi : 87 x/menit Spo2 : 97% on NRBM 12 lpm Suhu : 37 C RR : 27 x/menit; Akral : Dingin	DN
Kamis, 30/04/2026	20.00	Perawat "DN" memberikan terapi : - Ceftriaxone 1gr IV - Omeprazole 40mg IV - Ondansentron 4mg IV	DN



Kamis, 30/4/2026	21.00	Perawat siang "DN" operan jaga dengan perawat malam "NB" pasien atas nama Cariman/76 thn/BPJS 3 dengan DF + cardiomegali suspek CHF + DSS + Syok hipovolemik + AKI dd CKD st 3 + Bradikardia Keluhan : keluarga pasien mengatakan muntah 2x berisi cairan berwarna kuning dan sisa makanan ku cukup GCS 456 TD : 140/69 mmHg N : 105x/mnt S : 36,2 C RR : 21x/mnt Spo2 : 99% NRBM 12 lpm Akral : Dingin Rencana : Bisoprolol+Candesartan inisiasi bila NE stop EKG bacaan (-) DL serial tanggal 30/04/2026, dengan hasil : Hemoglobin : 10,4 g/dl Leukosit : 5.800 cell/ cmm Trombosit : 123.000 cell/cmm Hematokrit : 35,4 % BGA tanggal 30/04/2026, dengan hasil : pH : 7,23 pCO2 : 31 mmHg HCO3 : 12,9 mmol/L Dobutamin 10mcg ---> 7,2cc/ jam NE 0,3 jalan 6,7cc/jam (2 ampul) turun 0,1 mcg jalan 2,2 cc Jika HR < 50x/mnt berikan sulfat atropin 1 mg (diulang 5menit, max 3x) EKG ulang 01/05/2026 DL serial 01/05/2026	DN,NB
Kamis, 30/4/2026	21.57	Lapor hasil Lab dan kondisi ke dr. Dimas, Sp.PD via WA tanggal 30/4/2026 jam 21.48, Keluhan : keluarga pasien mengatakan muntah 2x, berisi cairan berwarna kuning dan sisa makanan TD : 140/69 mmHg N : 105x/mnt S : 36,2 C RR : 21x/mnt Spo2 : 99% NRBM 12 lpm Akral : Dingin Adv dr. Dimas,Sp.PD jam 21.57 Ne turun jadi 0.1 mcg Konsul ICU Pro Ventilator e.c gagal nafas	NB
Kamis, 30/04/2026	24.00	Perawat "NB" memberikan terapi : - Metamizole 1gr IV	



Jum'at, 01/05/2026	04:54	Perawat "NB" melakukan TTV Keluhan : pasien mengatakan muntah2, badan nyeri semua, ngonsrong KU cukup GCS 456 TD:139/77 mmHg Nadi:98 x/menit Spo2:98.00 NRBM 12 lpm Suhu:36.2 C RR:22 x/menit Akral : Dingin	NB
Jum'at, 01/05/2026	05.00	Perawat "NB" melakukan TTV Keluhan : pasien mengatakan muntah2, badan nyeri semua, ngongsrong lapor kondisi ke dr. dimas tanggal 1/5/2026 jam 03.32, adv dr. dimas jam 05.07 : Norepineprine turun 0.05 mcg, ns turun jadi 21 tpm	NB
Jum'at, 01/05/2026	06.00	Perawat "NB" memberikan terapi : - Metronidazole 500mg tab	NB
Jum'at, 01/05/2026	07.00	Perawat "NB" operan jaga dengan perawat zahro pasien atas nama Cariman/76 thn/BPJS 3 dengan DF + cardiomegali suspek CHF + DSS + Syok hipovolemik + AKI dd CKD st 3 + Bradikardia Perawat "ZR" melakukan observasi TTV didapatkan Keluhan : Pasien mengatakan mual muntah, sesak K/u Cukup GCS 456 TD : 110/803 mmHg Nadi : 88 x/menit Spo2 : 99 on NRBM 8 lpm Suhu : 36 C RR : 22 x/menit Akral : Dingin Planning : EKG ada 4 bacaan - Thorax bacaan Cardimegaly R/ ne 0,3 /kg bb 2 amp ==> 1,1 R/ dobutamin 10 mcg ==> 7,2 ns 20 tpm R/ Bisoprolol + Candesartan 8mg inisiasi jika NE Stop R/ Jika HR < 50x/menit berikan sulfat stropil; 1 mg (di ulang tiap 5 menit max 3 kali) R/ DL Serial 02/05/2026	Nabila, Zahro
Jum'at, 01/05/2026	08.00	Perawat "ZR" memberikan terapi : - Ceftriaxone 1gr IV - Omeprazole 40mg IV - Ondansetron 4mg IV	ZR



		- Metamizole 1gr IV	
Jum'at, 01/05/2026	11.57	Perawat "ZR" melakukan TTV Keluhan : pasien mengatakan mual muntah K/u cukup GCS 456 TD : 110/80 mmHg Nadi : 88 x/menit Spo2 : 99 on NRBM 8 lpm Suhu : 36 C RR : 22 x/menit; Akral : Dingin	ZR
Jum'at, 01/05/2026	14.00	Perawat "ZR" operan dinas siang dengan perawat Daniel pasien atas nama Cariman/76 thn/BPJS 3 dengan DF + cardiomegali suspek CHF + DSS + Syok hipovolemik + AKI dd CKD st 3 + Bradikardia Perawat "DN" melakukan observasi TTV kepada Tn. Cariman tiap jam dan mendokumentasikan observasi di ERM Planning : EKG ada 4 bacaan - NRBM 8 LPM DIIT CAIR 6X200CC R/ Echo 02/05/2026 NE pump 0,1 mcq => jalan 2,2 cc/ jam (2 ampul) Dobutamin pump 10 mcq => jalan 7,2 cc/jam NS 21 tpm R/ Bisoprolol + Cande inisiasi bila NE stop - jika HR <50 x/mnt berikan sulfat atropin 1mg (ulang tiap 5 mnt. max 3 mg) R/ DL serial 02/05/2026	ZR,DN
Jum'at, 01/05/2026	16.00	Perawat "DN" memberikan terapi : - Metamizole 1gr IV - Metronidazole 500mg tab	DN
Jum'at, 01/05/2026	18.24	Pasien dilakukan visite oleh dr.Aditya.,Sp.PD Keluhan : pasien mengatakan mual muntah TD:120/70 mmHg Nadi:70 x/menit Spo2:99.00 lpm Suhu:36 C RR:23 x/menit; Akral : Dingin A : gea+syok hipovolemik+df P : DL Serial	dr.Aditya.,Sp.PD
Jum'at, 01/05/2026	20.00	Perawat DN memberikan terapi : - Ondansetron 4mg IV - Omeprazole 40mg IV	DN
Jum'at, 01/05/2026	21.00	Pasien dilakukan TTV oleh perawat "JM" Keluhan : pasien mengatakan lemas, sesak k/u: Lemah, GCS 456	JM



		TD:120/70 mmHg Nadi:70 x/menit Spo2:99.00 on NRBM 8 lpm Suhu:36 C RR:23 x/menit; Akral : Dingin	
Jum;at, 01/05/2026	21.05	Perawat "DN" melakukan handover dengan Perawat "WN", pasien atas nama Tn. Cariman/76 thn/BPJS 3/ dengan DF + cardiomegali suspek CHF + DSS + Syok hipovolemik + AKI dd CKD st 3 + Bradikardia Rencana : EKG ada 4 bacaan (-) DIIT CAIR 6X200CC R/ Echo 02/05/2026 NE pump 0,1 mcq => jalan 2,2 cc/ jam (2 ampul) Dobutamin pump 10 mcq => jalan 7,2 cc/jam NS 21 tpm R/ Bisoprolol + Candesartan inisiasi bila NE stop (-) Jika HR <50 x/mnt berikan sulfat atropin 1mg (ulang tiap 5 mnt. max 3 mg) R/ DL serial 02/05/2026	DN, WN
Jum'at, 01/05/2026	24.00	Perawat WN memberikan terapi : - Metamizole 1gr IV	
Sabtu, 02/05/2026	05.00	Perawat WN melakukan TTV Keluhan : pasien mengatakan nyeri perut hilang timbul, sesak P : penyakit Q : tumpul R : perut S : 3 T : hilang timbul K/u Cukup GCS 456 TD : 80/75 mmHg Nadi : 89 x/menit Spo2 : 99% NRBM 10LPM Suhu : 36.7 C RR : 23 x/menit; Akral : Dingin	WN
Sabtu, 02/05/2026	06.00	Perawat WN memberikan terapi : - Metronidazole 1gr IV	WN
Sabtu, 02/05/2026	06.45	Perawat WN melakukan sampling DL serial kepada Tn. Cariman dan mengantarkan ke laboratorium Perawat Malam WN operan dg perawat pagi YN pasien atas nama Tn. Cariman/ 76Thn/ BPJS 3 dg DPJP dr. Dimas, Sp. PD raber dr. Dion, Sp. JP, pasien dengan kategori observasi ketat dan total care Diagnosa : DF + cardiomegali suspek CHF + DSS + Syok hipovolemik + AKI dd CKD st 3 +	WN,UN



		Bradikardia Keluhan : keluarga pasien mengatakan pasien mual, sesak, semalam sulit tidur dan nyeri perut Ku cukup GCS 456 TD : 73/56 mmHg N : 107x/mnt S : 36,8 C RR : 26x/mnt Spo2 : 99% NRBM 8 lpm Akral : Dingin Posisi semi fowler Px terpasang NGT no. 16 dan DC no. 16 Planning : - ECG pasien ada 4 Bacaan (-) - Diit cair 6x200cc - Echo dengan dr. Dion, Sp. JP bila px transportable - Jalan NE pump 0,1 mcgKgBB/jam -> jalan 2,2cc/jam (2 ampul oplos 50cc) - Jalan dua line Dobutamin 10mcg -> 7,2cc/jam - Jika TD stabil --> inisiasi bisoprolol dan candesartan sebelum NE stop (-) - Inf. NS 21 tpm - Observasi HR --->> jika HR < 50x/mnt makan diberikan sulfat atropin 1 mg (diulang 5menit, max 3x) - DL serial 02/05/2026	
Sabtu, 02/05/2026	07.00	Perawat WN, operan jaga dengan perawat YN atas nama Tn. Cariman/76 thn/BPJS 3 dengan DF + cardiomegali suspek CHF + DSS + Syok hipovolemik + AKI dd CKD st 3 + Bradikardia Perawat YN melakukan TTV didapatkan keluhan : pasien mengatakan nyeri perut hilang timbul, sesak TD:78/57 mmHg Nadi:80 x/menit Spo2:97.00 lpm >>> NRBM 15 lpm Suhu:36 C RR:28 x/menit Gcs :456 Akral : Dingin	YN
Sabtu, 02/05/2026	08.00	Perawat YN memberikan terapi : - Ceftriaxone 1gr IV - Ondansetron 4mg IV - Omeprazole 40mg IV - Metamizole 1gr IV	YN
Sabtu, 02/05/2026	08.02	Pasien dilakukan visite oleh dr.Dimas.,Sp.PD S : pasien mengatakan nyeri perut hilang	dr.Dimas.,Sp.PD



		timbul, sesak p: penyakit q; tumpul r: perut s: 3 t: hilang timbul O : TD:96/45 mmHg Nadi:110 x/menit Spo2:98.00 lpm Suhu:36 C RR:24 x/menit; Akral : Dingin plt = 56.000 , hb= 8,9 A : DF + cardiomegali suspek CHF + DSS + Syok hipovolemik + AKI dd CKD st 3 + Bradikardia P : pdx ur cr ulang , albumin , dl serial ptx= dobutamin 10 mcg ; ne 0,1 mcg, takar urin , tx lain lanjut, saran echo evaluasi ivc untuk status hidrasi	
Sabtu, 02/05/2026	12.00	Perawat yuan memberikan terapi : - Metronidazole 50mmg	YN
Sabtu, 02/05/2026	12.15	Pasien dilakukan Echocardiogram oleh dr.Dion Setiawan,Sp.JP, dengan hasil : HF Preserved EF (80%) kesan hiperkinetik ec hipovolum Shock condition dt hypvolemic dd septic Drip NE dapat dilanjutkan usul pemberian loading cairan 500cc dalam 30 menit kalau tidak sesak dan TD serta nadi perbaikan bisa diberikan 500cc lagi Bila tensi perbaikan bisa tapering down dobutamin beta blocker dan ace-i saran diberikan bila sudah lepas topangan.	dr.Dion.,Sp.JP
Sabtu, 02/05/2026	13.00	Perawat YN lapor kondisi dan hasil Echo dr. Dion Sp.JP ke dr. Dimas Sp.PD pada tanggal 02/05/2026 pukul : 13.10 Keluhan : pasien mengatakan sesak , tidak nafsu makan GCS 456 KU : Lemah TD:87/65 mmHg Nadi:70 x/menit Spo2:97 on NRBM 15 lpm Suhu:36 C RR:28 x/menit; Akral : Dingin Dibalas dr. Dimas Sp.PD tangal 02/05/2026 pukul 13.15 : "Konsul icu suspek gagal nafas, cek bga	YN



		ulang"	
Sabtu, 02/05/2026	13.24	Perawat IZ melakukan TTV Keluhan : pasien mengatakan nyeri perut hilang timbul, sesak p: penyakit q; tumpul r: perut s: 3 t: hilang timbul TD:78/57 mmHg Nadi:80 x/menit Spo2:97.00 on NRBM 15 lpm Suhu:36 C RR:28 x/menit; Akral : Dingin	IZ
Sabtu, 02/05/2026	14.00	Perawat pagi YN, operan jaga dengan perawat siang ZR atas nama Cariman/76 thn/BPJS 3 dengan DF + cardiomegali suspek CHF + DSS + Syok hipovolemik + AKI dd CKD st 3 + Bradikardia KU lemah GCS : 223 TD:87/65 mmHg Nadi:70 x/menit Spo2:97.00 lpm NRBM 15 lpm Suhu:36 C RR:28 x/menit Akral : Dingin Pasien rencana : R/ Jln ne 0,1 mcg kg/bb (2 amp) -> 2,2 cc/jam R/ dobutamin 10mcg kg/bb -> 7,2 cc/jam R/ Inf ns 21 tpm R/ Echo dengan dr. dion (saran echo evaluasi ivc untuk status hidrasi) (+) R/ Bisoprolol + Candesartan inisiasi bila Norepineprine stop jika HR <50x/mntberi SA 1mg selang5 menit max 3 mg R/ Observasi TTV R/ DL serial 02/05/2026 (+), hasil : R/ dl serial besok botol (-) R/ cek ur/cr/albumin (+) lapor (+) balasan (-) R/ pindah ICU pasien masih berunding belum ada keputusan	YZ,ZR
Sabtu, 02/05/2026	15.02	Perawat NB melakukan TTV Keluhan : pasien penurunan kesadaran, sesak KU : lemah GCS 111 TD:78/63 mmHg N : 62 x/menit Spo2:89.00 lpm on JR 15lpm	NB

		S : 36 C RR : 28x/menit Akral : Dingin	
Sabtu, 02/05/2026	15.44	Perawat ZR mengaktifkan code blue dr. Dicky naik ke ruangan : Pasien henti jantung, henti nafas TD : - N : - RR : - SpO2 : - Akral : Dingin Pupil : Midriasis Adv : RJP 25 siklus Inj Epinephrin 4 amp KIE Keluarga Pasien dinyatakan meninggal pukul 15.37	dr.Dicky

Menyetujui

Direktur RS Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari,S.Kep.,M.Kep

Pembuat Kronologi

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

(Ns. Sinta Olivia R,S.Kep)